

肺癌:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 肺癌の薬薬連携 — 経口TKI・ペメトレキセド・ILD

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① ドライバー遺伝子・PD-L1の結果とレジメンの整合性を監査	⇒ ドライバー遺伝子 (EGFR・ALKなど)	⇒ ① 経口TKIの服用時点を確認(エルロチニブは空腹時)
② ペメトレキセドの葉酸・ビタミンB12前投与を確認	⇒ 葉酸・B12の開始日 (ペメトレキセド)	⇒ ② 胃薬(PPI・H2遮断薬)とEGFR-TKIの併用を確認
③ ICI併用療法(irAE発症時の院内連携)	⇒ 皮疹・下痢の程度 (EGFR-TKI)	⇒ ③ ロルラチニブの脂質・気分の変化、アレクチニブの筋肉痛を聴取
④ ILD発症時の中止判断と再投与の可否の検討	⇒ 咳・息切れ・発熱 (ILDの早期発見)	⇒ ④ 皮疹・爪囲炎のスキンケア指導と外用薬の使い方
⑤ アミバンタマブ等のインフュージョンリアクション対策		⇒ ⑤ 咳・息切れ・発熱を来局ごとに聴取(ILD)

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

CDDP+PEM 点滴・注射	シスプラチン+ペメトレキセド(維持療法はペメトレキセド単剤)	3週毎	✓ 葉酸・ビタミンB12の前投与 ✓ 腎機能低下時のNSAIDs併用 ✓ 大量補液
オシメルチニブ 経口	80mg 1日1回 連日内服	連日	✓ QT延長薬の併用 ✓ 乾性咳嗽・息切れ(ILD) ✓ 爪囲炎
アレクチニブ 経口	300mg 1日2回 連日内服	連日	✓ 筋肉痛・CK上昇 ✓ 便秘 ✓ 光線過敏(日焼け対策)
ロルラチニブ 経口	100mg 1日1回 連日内服	連日	✓ 脂質異常症(定期的な脂質検査) ✓ 気分・認知の変化 ✓ リファンピシンは併用禁忌
ROS1阻害薬 経口	レボレクチニブ 1日1回14日間→1日2回/タレレクチニブ 1日1回 空腹時	連日	✓ めまい・ふらつき(転倒・運転) ✓ 味覚障害 ✓ 肝機能
HER2変異TKI 経口	セバベルチニブ 1日2回 食後/ゾンゲルチニブ 1日1回	連日	✓ 下痢(止瀉薬を携帯) ✓ 肝機能 ✓ 咳・息切れ

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書併用禁忌	ロルラチニブ CYP3A4誘導	処方薬 リファンピシン(抗結核薬)	重篤な肝障害・効果減弱	併用しない。他院の抗結核薬の処方を確認
注意 添付文書併用注意	ゲフィチニブ・エルロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓→効果減弱	市販のH2ブロッカーも確認、服用時間を調整
注意 添付文書併用注意	オシメルチニブ等・EGFR・ALK阻害薬 CYP3A4誘導	処方薬 カルバマゼピン・フェニトイン・リファンピシン	血中濃度↓→効果減弱	他院の抗てんかん薬・抗結核薬を確認
注意 添付文書併用注意	エルロチニブ CYP1A2誘導	生活習慣 喫煙	血中濃度↓→効果減弱	喫煙状況を確認し禁煙を支援
注意 添付文書併用注意	ペメトレキセド 胃排泄の低下	処方薬 市販薬 NSAIDs(市販の解熱鎮痛薬も)	骨髄抑制・粘膜障害↑	投与前後の市販鎮痛薬の使用を聴取
確認 添付文書用法・用量	ペメトレキセド 前投与の不足	処方薬 葉酸の毎日の服用・ビタミンB12注射	骨髄抑制・粘膜障害↑	葉酸の飲み忘れがないか確認

4 服薬指導タイムライン — 肺癌の治療に合わせて

① 治療開始前	② TKI開始1~4週	③ ペメトレキセド投与中	④ 治療中はいつでも
“この薬は毎日同じ時間に飲み続けることで効果を保ちます。飲み忘れた時の対応も一緒に確認しましょう”	“顔や胸のニキビのような発疹は、保湿と早めの塗り薬で抑えられます。我慢せず教えてください”	“葉酸は毎日、治療が終わってからもしばらく飲み続けます。飲み忘れないようにしましょう”	“息切れや空咳が続く時、熱を伴う時は、次の受診を待たずに連絡してください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳でドライバー遺伝子・治療ライン、併用薬(胃薬・QT延長薬・CYP3A4関連)	✓ 薬局で確認 電話フォローで皮疹・下痢のGrade、保湿剤・外用薬の使い方	✓ 薬局で確認 葉酸の服用状況、ビタミンB12注射の予定(9週ごと)	✓ 薬局で確認 来局ごとに咳・息切れ・発熱、ICIでは倦怠感・口渴・動悸を聴取
△ ここに注意 ペメトレキセドは葉酸・B12の前投与を開始済みか	△ ここに注意 水様便が1日4回以上増える時は連絡	△ ここに注意 葉酸を自己判断でやめると骨髄抑制が強まるおそれ	△ ここに注意 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い至急受診